

INFILTRACIÓN DE MUÑECA

Manuel Ángel Ochoa Vilor, Raquel García González, Julio Tito Camino Acha, Juan José González Fernández.

INTRODUCCIÓN

La infiltración de muñeca es una técnica diagnóstica y terapéutica muy útil en el área de atención primaria y también en la urgencia.

INDICACIONES

- Síndrome del túnel del carpo
- Artritis inflamatoria de la articulación trapeziometacarpiana (Rizartrosis)
- Tenosinovitis de De Quervain
- Tenosinovitis de los flexores digitales profundo y superficial (dedo en resorte) Ganglión.

OBJETIVOS

- Tratar el dolor de forma crónica y aguda en artralgiás
- Disminuir la limitación de movimientos en patologías tendinosas
- Disminuir la necesidad de tratamientos más invasivos

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

- Explorar y marcar el punto de entrada de la aguja.
- Cargar la jeringuilla con el medicamento a inyectar
- Asepsia y antisepsia de la zona a infiltrar con povidona yodada
- Asepsia y antisepsia de manos y colocación de guantes estériles
- Compresión ulterior de la zona para evitar sangrados

Síndrome del túnel del carpo

Se debe palpar bien la cresta proximal de la muñeca y el tendón palmar largo, que se localiza mejor con los dedos flexionados, y la muñeca en una posición neutra. La infiltración se lleva a cabo en un lugar inmediatamente cubital al tendón palmar largo del carpo y en la cresta proximal de la muñeca. Para los pacientes que no tengan tendón largo del carpo la infiltración se realizará sobre la línea media de la muñeca. La aguja se inserta con una angulación de 30 grados y dirigida hacia el dedo anular.



Si la aguja se encuentra con una obstrucción o el paciente comienza tener parestesias se redirigirá la aguja hacia una zona más cubital. Otro lugar de infiltración es la cara palmar del antebrazo, 4 cm proximal a la cresta de la muñeca, entre los tendones del flexor radial y el palmar

largo. El ángulo de inserción debe ser entre 10 y 20 grados. Hay que hacer la infiltración despacio pero con presión continuada.

Rizartrosis

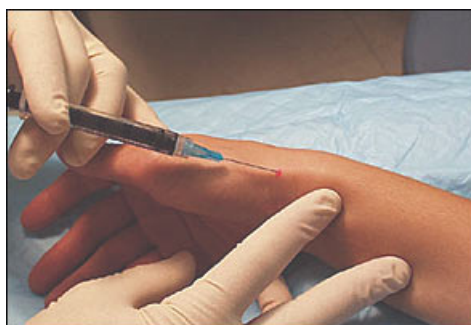
Se debe palpar el espacio articular entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

La aguja debe entrar proximal al primer metacarpiano por la cara extensora de la muñeca. Hay que tener precaución para no lesionar la arteria radial o el tendón pollicis. Para evitar la arteria la aguja debería de entrar hacia la cara dorsal del extensor pollicis corto. Se puede aplicar tracción al dedo pulgar para mayor apertura del espacio articular.



Tenosinovitis de Quervain

Con el pulgar en abducción y extensión se debe palpar el trayecto de los tendones, distalmente a la apófisis estiloides radial. La aguja se coloca en el primer compartimento extensor, proximal a la estiloides radial y deslizándose en paralelo hacia los tendones abductor largo y extensor corto, con precaución de no atravesarlos.



Tenosinovitis del flexor digital

Normalmente se palpa un nódulo secundario a la tenosinovitis sobre la cabeza del metacarpiano del tendón afectado, que es el que produce el resorte del dedo. La aguja se coloca sobre la superficie palmar, distalmente a la cabeza del hueso metacarpiano con un ángulo de 30 grados de inclinación y luego más próximamente prácticamente en paralelo a la piel, hacia la zona lesionada. Se infiltra dentro de la vaina, no intratendinoso.



Ganglión

Se deben palpar los bordes del quiste, aspirar el contenido e infiltrar corticoides si es necesario.

MATERIAL

- Una jeringuilla de 5ml con agujas desechables intramuscular y subcutáneas
- Campo, gasas y guantes estériles
- Povidona yodada y alcohol 70%
- Anestésico: 2-3 ml al 1% de lidocaína o buvipacaína 0,25%.
- Corticoide: 1 ml de Celestone o 40 mg/ml de metilprednisolona.



Lo que no se debe de olvidar en urgencias

- Espaciar semanalmente las infiltraciones para valorar el resultado.
- No infiltrar en cada sesión más de 2 articulaciones por la posibilidad de mayor absorción sistémica.
- El paciente deberá de permanecer en posición de supino durante varios minutos tras la infiltración.
- Se debe mover la articulación infiltrada de forma pasiva para comprobar que la técnica ha sido efectiva.
- Avisar al paciente de que los síntomas previos pueden empeorar durante las siguientes 48 horas, que tratarán con AINEs y hielo local.

BIBLIOGRAFÍA

- Manual de infiltraciones en Atención primaria. Consellería de Sanitat, Comunidad Valenciana. 2007. José Sanfélix Genovés
- Diagnosis and therapeutic injection of the wrist and hand región. Alfred M.Tallia, M.D, M.P.H and Denis A. Cardone.
- Lizan Tudela L, Balanzá Garzón A. Guía de actuación en atención primaria. Barcelona: Semfyc; 2006. p. 1746-52.